

3 血痰、咯血 bloody sputum, hemoptysis

到達目標

- 咯血の原因疾患を列挙できる
- 咯血の原因を鑑別するための諸検査を列挙できる
- 咯血時の治療、処置について概説できる

定義

血痰・咯血は気管および下気道からの出血を咯出したものであり、通常は咳嗽を伴う。痰の中に血液が混じる程度のものを血痰といい、ほとんど血液だけを咯出するものを咯血というが、両者を区分する明確な基準はない。咯血は一度に2～5 mL以上の血液が咯出される状態とされ、一般的には100～600 mL/day以上の咯血を大量咯血とすることが多いが、臨床的に咯血量を正確に測定することは不可能であり、咯血診療指針¹⁾では、200 mL/日以上、コップ1杯または酸素飽和度90%以下を重症咯血、15 mL/日未満、大さじ1杯を軽症、その間を中等症としている。

病態・原因疾患

咯血の起原は気管支動脈系由来が多くおよそ90%を占め²⁾、肺動脈系由来の出血は少ない。まれに体循環動脈-肺動脈吻合からの出血もある。一般に気管支動脈あるいは体循環動脈由来の咯血は量が多い。

血痰・咯血の原因疾患は多岐にわたり(表1)、わが国におけるこれらの疾患の咯血原因としての頻度は明らかでない。日常臨床で多くみられるのは、気管支拡張症、肺結核後遺症など既存の肺病変に感染を合併して生ずる咯血であるが、肺癌も咯血原因の約10%を占めるとされる³⁾。

診断

- a 病歴、問診(口腔、咽頭からの出血および吐血との鑑別)
- 鼻出血が気道内に吸引されて咳嗽を伴うこともあり、注意が必要で咽頭や喉頭からの出血が疑われれば耳鼻科診察も考慮する。口腔内の出血であれば唾液に血液が混じる。また救急の場面では吐血との鑑別が問題になることがある。表2に吐血と咯血の鑑別点を

表1 血痰・咯血の原因疾患

気道病変		・ 気管支拡張症 ・ 気管支炎 ・ 気道内異物 ・ 気道損傷、外傷 ・ 気管支血管腫(気管支大動脈腫、気管腕頭(無名)動脈腫) ・ 気管支結石症
肺病変	感染症	・ 肺炎(ブドウ球菌、クレブシエラなど)、閉塞性肺炎 ・ 肺膿瘍 ・ 肺結核(活動性結核性空洞) ・ 非結核性抗酸菌症 ・ 肺真菌症(アスペルギルス症、ムコール症)
	免疫異常	・ 多発血管炎性肉芽腫症 ・ 肺胞出血(膠原病(レーブス肺炎) 血管炎症候群 Goodpasture 症候群 特発性肺ヘモジデロシス 薬剤性)
	その他	・ 肺結核後遺症
腫瘍性病変		・ 肺癌 ・ 転移性肺腫瘍 ・ 気管腫瘍
心血管異常		・ 心不全、肺水腫、肺うっ血 ・ 肺血栓塞栓症 ・ 僧帽弁狭窄症 ・ 肺動静脈瘻
その他		・ 医原性(肺穿刺、胸腔穿刺、気管支鏡検査などの合併症) ・ 抗凝固薬使用 ・ 血小板減少症 ・ 凝固異常(先天性、後天性) ・ 月経随伴咯血 ・ コカイン中毒、覚醒剤中毒
特異性		・ 原因不明のもの

[藤田次郎：日医師会誌 137 (特別号2)：72, 2008 より作成]